Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Taquara

Rua Ernesto Alves, 1750 - Bairro: Recreio - CEP: 95600354 - Fone: (51) 3098-5589 - Balcão Virtual: (51) 99996-1265 - Email: frtaquara1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001513-71.2022.8.21.0070/RS

AUTOR: JOAO PAULO CAMBRAIA DAL MOLIN

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

J.P.C.D., menor representado por sua genitora, Cinthia Cambraia Dal´molin, ajuizou ação de obrigação de fazer em face de UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS. Aduziu que apresenta defasagem de desenvolvimento em relação à fala, compreensão reduzida da linguagem verbal, hipotonia motora (inclusive oral), dificuldade de repertório funcional e adequado à idade quanto à socialização, além de outros sintomas. Em razão do quadro apresentado, foram indicados os seguintes procedimentos terapêuticos: quinze horas por semana de aplicação do Modelo Denver de intervenção precoce com uma hora semanal de supervisão, uma hora semanal de psicoterapia para realinhamento das estratégias comportamentais e orientação parental sistemática, terapia ocupacional duas vezes por semana, terapia fonoaudiológica duas vezes por semana e musicoterapia duas vezes por semana. Ademais, foram determinados os seguintes procedimentos investigativos: ressonância magnética do encéfalo, eletroencefalograma (EEG), avaliação com otorrinolaringologista, investigação com geneticista e testagem psicológica/ neuropsicológica. Requeridos os procedimentos, foram indicadas clínicas para atendimento da aplicação do Modelo Denver e da psicoterapia para realinhamento das estratégias comportamentais e orientação parental sistemática, foi negada a musicoterapia e sobre os demais tratamentos foi solicitado o envio de certificados dos profissionais para análise pelo requerido, documentos que foram encaminhados, porém não houve retorno do plano. Acerca dos procedimentos investigativos foi autorizada a testagem psicológica/ neuropsicológica, sendo indicada clínica. Aduziram que para fins de aplicação dos procedimentos autorizados pelo plano, solicitaram comprovantes de qualificação dos profissionais indicados, o que foi negado pelo plano e pelas clínicas indicadas. Referiram, ainda, que quando ao Modelo Denver, mostra-se indispensável que o procedimento seja aplicado em ambiente controlado o (clínica), semiestruturado (casa/escola) e natural (casa/escola e saídas), porém a clínica indicada (Clínica Psicomed) não presta tal serviço, ao que foi solicitado nova indicação, quedando-se silente a requerido. Especificaram a cobrança de coparticipação, pois entendem devida somente em caso de sessões ambulatoriais, sendo indevidas em caso de terapias multiprofissionais. Defenderam que o requerido se negou a prestar as informações adequadas ao atendimento médico necessário, referindo que obrigou-se a procurar atendimento fora da rede credenciada, custeando de forma particular as sessões do tratamento. Discorreu acerca da indispensabilidade dos tratamentos nos exatos termos dos laudos médicos, redução da coparticipação para 30%, ausência de informação adequada acerca da coparticipação e do direito à continuidade do tratamento. Sustentou que os gastos com o tratamento realizado até o momento devem ser ressarcidos, no montante de R$ 20.233,50. Pediu, em liminar, (i) a liberação dos procedimentos de testagem psicológica/ neuropsicológica, aplicação do Modelo Denver (ESDM), psicoterapia para alinhamento de estratégias comportamentais e orientação parental sistemática, mediante reembolso dos profissionais que já atendem o demandante, (ii) liberação das terapias de supervisão do Modelo Denver (ESDM), terapia ocupacional com integração sensorial e treino de habilidades de vida diária certificação internacional em Integração Sensorial Ayres, fonoaudiologia PROMPT e tecnologia assistiva seja realizada mediante reembolso, (iii) liberação do procedimento de musicoterapia mediante reembolso, (iv) que todos os tratamentos sejam liberados em quantidade e nos moldes da receita médica, em local com estrutura e material adequados, por profissionais capacitados, mantendo-se o vínculo do paciente com o terapeuta e mediante garantia de inalteração do terapeuta, (v) determinar que das terapias liberadas por reembolso seja garantida a continuidade de prestação de tratamento, (vi) redução da coparticipação de 50 para 30% e (vii) determinar a isenção da coparticipação nos procedimentos Modelo Denver e musicoterapia ou redução da coparticipação para 30% e, ao final, (i.i) a confirmação das medidas em sede antecipação tutela, (i.ii) a condenação da requerida ao ressarcimento do montante de R$ 20.233,50. Requereu o benefício da gratuidade de justiça (evento 1, INIC1).

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (evento 13, DESPADEC1). Em face da decisão foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento (evento 16, ACOR2).

O pedido liminar foi indeferido (evento 24, DESPADEC1). Interposto agravo de instrumento em face da decisão, ao qual concedido provimento, determinando a realização das terapias prescritas em laudo médico, mediante reembolso, fora da rede credenciada, inclusive musicoterapia, observada a coparticipação no patamar de 40% (evento 31, DEC LIM TUTELA2).

A inicial foi recebida (evento 33, DESPADEC1).

As partes foram intimadas para dizer sobre interesse na dilação probatória (evento 49, CONT1).

Unimed apresentou contestação (evento 49, CONT1). Impugnou o valor atribuído à causa, referindo que inexiste proveito econômico imediato, figurando como inestimável o valor da causa, pois objetiva a demanda a preservação da saúde. No mérito, aduziu que o demandante é beneficiário de contrato de assistência à saúde, plano individual/ familiar PMGN1A PLANO MÉDICO NACIONAL PRIVATIVO, desde 01/01/2013, tratando-se de contrato regulado pela Lei nº 9.656/1998. Referiu que todos os tratamentos possuem cobertura contratual, seja através da rede credenciada, seja por reembolso, devendo ser observada a coparticipação. Aduziu que todos os tratamentos foram autorizados mediante reembolso, reiterando que deve ser observado o pagamento da coparticipação, conforme relação contratual entabulada entre as partes, que perfez o total de 66%. Discorreu acerca do direito de cobrança da coparticipação, referindo que em caso de redução, não poderá o percentual ser inferior a 50%, conforme recente jurisprudência do STJ. Refutou o ressarcimento integral das

despesas relativas ao tratamento em momento anterior ao ajuizamento da demanda, referindo que deve ser reduzida a quota de coparticipação. Esclareceu que os relatórios de atendimento e respectivas notas fiscais devem ser encaminhados mensalmente, de modo a viabilizar o pagamento dos atendimentos, bem como prescrição médica atualizada a cada seis meses. Pugnou pelo acolhimento da impugnação ao valor da causa e improcedência dos pedidos da inicial.

O demandante pediu (i) intimação da requerida acostar ao feito comprovante de pagamento dos profissionais que atendem o demandante, (ii) em caso de possuir credenciados aptos a aplicação dos tratamentos, que apresente termo de credenciamento, comprovante de qualificação para a metodologia indicada, declaração do profissional informando que possui disponibilidade horária de atendimento e informando de qual é essa disponibilidade e (iii) concessão de prazo de 30 dias para juntar as avaliações terapêuticas. Apresentou réplica à contestação (evento 52, PET1).

A preliminar de impugnação ao valor da causa foi afastada e foi determinada a inversão do ônus da prova (evento 58, DESPADEC1).

O demandante desistiu da dilação probatória e ambas as partes pediram o julgamento antecipado do feito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato.

Decido.

Conforme reconhecido em contestação, a parte demandada autorizou a realização de todos os procedimentos solicitados à inicial, em clínica que já atende o demandante e mediante reembolso. Dessa forma, infiro que os procedimentos terapêuticos e investigativos foram devidamente autorizados, conforme requisitos inseridos no laudo médico, inexistindo controvérsia acerca do ponto, cabendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto da demanda.

Consigno que os seguintes procedimentos terapêuticos foram autorizados e estão sendo cumpridos:

- Modelo Denver de Intervenção Precoce - Quantidade: 15h/semanais de aplicação + 1h/semanal de supervisão; Qualificação: Supervisor deve ter certificação pelo Mind Institute da Califórnia, enquanto aplicador deve possuir formação no Workshop introdutório do modelo DENVER; Local: Ambiente controlado (clínica), semiestruturado (casa/escola) e natural (casa/escola e saídas);

- Psicoterapia para alinhamento das estratégias comportamentais e orientação parental sistemática - Quantidade: 1h/semanal; Qualificação: ABA, DENVER e TEACCH; Local: Clínica e observações em ambiente natural;

- Terapia ocupacional com intuito de treino de habilidades da vida diária e integração sensorial - Quantidade: 2 vezes/semana; Qualificação: Certificação internacional em Integração Sensorial de Ayres; Local: Sala sensorial ou parte sensorial que siga as medidas de fidelidade de Integração Sensorial de Ayres.

- Terapia fonoaudiológica - método PROMPT; Quantidade: 2 vezes/semana; Qualificação: Formação PROMPT; Local: Clínica;

- Musicoterapia - Quantidade: 1 vez/ semana; Qualificação: Graduação em musicoterapeuta; Local: Clínica;

- testagem psicológica e neuropsicológica.

Resta analisar as questões relativas à redução da coparticipação de 66% para 30% e o ressarcimento das despesas dos procedimentos realizados em momento anterior ao ajuizamento da demanda.

A controvérsia deve ser dirimida a luz da Lei nº 9.656/1998, não se olvidando acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor - aplicada de forma subsidiária, nos termos do verbete sumular nº 608 do Superior Tribunal de Justiça: "*aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

De efeito, tanto o CDC em seu art. 4º, quanto a Lei nº 9.656/1998 em seu art. 35-G, priorizam a transparência e a harmonia entre as partes da relação, consumidor e operadora de plano de saúde, devendo ser observada a proteção dos interesses econômicos da pessoa jurídica, sem o descuido dos interesses do paciente. Para tanto, as normas citadas devem ser interpretadas em consonância com aquilo que previamente acordado entre as partes.

Não há dúvidas acerca da legalidade da cobrança da coparticipação pelas operadoras de plano de saúde, conforme autorizado pelo art. 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998, situação que viabiliza a garantia do equilíbrio contratual. Entretanto, deve-se evitar a fixação de coparticipação que limite o acesso aos serviços de saúde indispensáveis à saudável manutenção da saúde e da vida do beneficiário. Em forma simples, objetiva-se evitar condutas abusivas, que possam desvirtuar o contrato de saúde.

Nesse sentido, aliás, veja-se o Informativo nº 586 do STJ:

> ***Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços.*** *De fato, o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Nos termos do art. 3º, I e II, da Resolução n. 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), franquia é o valor estabelecido no contrato de plano de saúde até o qual a operadora não tem responsabilidade de cobertura, e a coparticipação é a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora referente à realização de determinado procedimento, que se soma à mensalidade. Cumpre destacar que esses fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas*

inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário, visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento. Desse modo, pela própria natureza do instituto, a adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento. Logo, não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998) é expressão da lei. O que é vedado, todavia, é a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a exemplo de financiamentos quase integrais do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora. Em outras palavras, não é possível atribuir ao usuário de plano de saúde, sob o disfarce da coparticipação, o custeio da maior parte das despesas médicas, impedindo-o de usufruir dos serviços de assistência à saúde contratados. Ademais, especificamente sobre a coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento, cabe ressaltar que sua previsão é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo, no lugar, ser os valores prefixados. É o que determinam os arts. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU: "Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados: [...] VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços; VIII - estabelecer em casos de internação, fator moderador em forma de percentual por evento, com exceção das definições específicas em saúde mental. [...] Art. 4º As operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, quando da utilização de mecanismos de regulação, deverão atender às seguintes exigências: [...] VII - estabelecer, quando optar por fator moderador em casos de internação, valores prefixados que não poderão sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias." Por fim, o afastamento de cláusula de coparticipação equivaleria a admitir-se a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual. ***REsp 1.566.062-RS,*** *Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016, DJe 1/7/2016*

Colaciono jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, de modo a corroborar o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO. VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. SERVIÇOS. FATOR DE RESTRIÇÃO SEVERA. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO.

1. Os planos de saúde, instituídos com o objetivo de melhor gerir os custos da assistência privada à saúde, podem ser integrais (completos) ou coparticipativos.

2. O art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 permitiu a inclusão de fatores moderadores, paralelos às mensalidades, no custeio dos planos de saúde, como a coparticipação, a franquia e os limites financeiros, que devem estar devidamente previstos no contrato, de forma clara e legível, desde que também não acarretem o desvirtuamento da livre escolha do consumidor. Precedente.

3. A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário, que, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

4. Os fatores moderadores de custeio, além de proporcionar mensalidades mais módicas, são medidas inibitórias de condutas descuidadas e pródigas do usuário visto que o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames afetará negativamente o seu patrimônio. A prudência, portanto, figura como importante instrumento de regulação do seu comportamento.

5. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora.

6. A coparticipação em percentual sobre o custo do tratamento é proibida apenas nos casos de internação, e somente para os eventos que não tenham relação com a saúde mental, devendo ser os valores prefixados (arts. 2º, VII e VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/1998).

7. O afastamento da cláusula de coparticipação equivaleria a admitir a mudança do plano de saúde para que o usuário arcasse com valores reduzidos de mensalidade sem a necessária contrapartida, o que causaria grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, a qual teria que custear a integralidade do tratamento.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.695.118/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Na mesma linha, prevê o art. 2º, inciso VII, da Resolução CONSU nº 08/2018:

Art. 2º. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços.

Na hipótese dos autos, o contrato prevê coparticipação nos seguintes limites (evento 49, CONTR2, fl. 17):

Clausula Sexagesima Primeira A CONTRATADA garante ao beneficiario que a autorizaçao previa para realização de procedimentos ou o atendimento concedido pelo seu serviço de regulaçao se dara no prazo maximo de 1 (um) dia util a partir do momento da solicitaçao ou, em prazo inferior, quando caracterizada a urgência

Clausula Sexagesima Segunda A CONTRATADA cobrara o valor correspondente as seguintes copartıcipações
I - 40% (quarenta por cento) nas consultas previstas neste contrato excetuadas as descritas nos incisos V e VII desta clausula,
II 40% (quarenta por cento) sobre o valor das sessões fisiatricas (reeducação e reabilitação fisica),
III 40% (quarenta por cento) sobre o valor dos atendimentos e/ou sessões de acupuntura
IV 40% (quarenta por cento) sobre o valor de cada sessão de oxigenoterapia hiperbarica
V 66% (sessenta e seis por cento) do valor das consultas medico psiquiatricas, atendimentos psicoterapicos e tratamentos em hospital dia para transtornos mentais,
VI 50% (cinquenta por cento) do valor das internações decorrentes de transtornos psiquiatricos que ultrapassem 30 (trinta) dias de internação no transcorrer de 1 (um) ano de contrato
VII 66% (sessenta e seis por cento) do valor das consultas e/ou sessões de terapia ocupacional fonoaudiologia foniatria e nutricionista,
VIII 30% (trinta por cento) sobre o valor dos honorarios medicos de cada procedimento videoendoscopico e videolaparoscopico previstos neste contrato, exceto Refluxo Gastroesofagico, Apendicectomia, Colecistectomia, Esplenectomia parcial/total

Herniorrafia inguinal recidiva bilateral ou complementar a outro procedimento videolaparoscopico (VLP) Adrenalectomia unilateral Ooforectomia unilateral/bilateral, Laqueadura Miomectomia uterina Salpingectomia unilateral/bilateral, Liberação laparoscopica de aderências pelvicas, Laparoscopia ginecologica com/sem biopsia Gravidez ectopica e Simpatectomia por videotoracoscopia

De acordo com o contrato, a coparticipação corresponde a 66% do valor dos procedimentos terapêuticos e investigativos. A coparticipação como prevista em contrato, conforme já reconhecido em sede liminar, inviabiliza a manutenção dos tratamentos terapêuticos, uma vez que tratam de procedimentos contínuos, quais sejam: Modelo Denver de Intervenção Precoce, Psicoterapia para alinhamento das estratégias comportamentais e orientação parental sistemática, Terapia ocupacional com intuito de treino de habilidades da vida diária e integração sensorial, Terapia fonoaudiológica - método PROMPT e Musicoterapia.

Dessa forma, mostra-se admissível a readequação do montante relativo a coparticipação em relação aos tratamentos contínuos, devendo ser fixada em 40% do custo do tratamento.

Em relação ao procedimento investigativo, testagem psicológica/neuropsicológica, entendo que por tratar de procedimento esporádico e não contínuo, deve ser mantida a coparticipação prevista em contrato.

Assim sendo, em relação ao valor a ser ressarcido, R$ 20.233,50 (vinte mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), deve ser aplicada a coparticipação no montante de 40%, perfazendo, assim, ressarcimento no valor total de R$ 12.140,10 (doze mil cento e quarenta reais e dez centavos).

DISPOSITIVO

Forte no art. 485, inciso IV, do CPC, JULGO EXTINTOS os pedidos formulados por J.P.C.D., menor representado por sua genitora, Cinthia Cambraia Dal´molin, em face de UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA, em relação aos pedidos de liberação e autorização dos procedimentos; ainda, forte no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para:

a) revisar a coparticipação nos procedimentos **contínuos**, fixando a coparticipação em 40% do custo do tratamento;

Em relação ao procedimento investigativo, testagem psicológica/neuropsicológica, entendo que por tratar de procedimento esporádico e não contínuo, deve ser mantida a coparticipação prevista em contrato.

b) condenar a parte requerida a ressarcir a parte demandante o montante de R$ 12.140,10 (doze mil cento e quarenta reais e dez centavos), relativo à diferença do valor da coparticipação nos montantes já adimplidos a título de tratamentos da parte demandante. O valor deve ser atualizado pelo IPCA desde o desembolso, com juros de mora de 1% a contar da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento da taxa judiciária e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da parte demandada, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o que faço em atenção aos pressupostos do art. 85, §2º, do CPC.

Agendada a intimação eletrônica das partes.

Documento assinado eletronicamente por **EVELISE MILEIDE BORATTI, Juíza de Direito**, em 15/2/2024, às 15:16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054479125v3** e o código CRC **52d0ff14**.